

長照常用評估量表說明

SPMSQ • 巴氏量表 • IADL • GDS-15

授課教師：王三源 課程助教：古珉瑄（醫資所） 臺北醫學大學 智慧醫療學士學位學程

W5 的模擬資料使用了四個長照現場常用的評估量表。做資料分析之前，要先弄懂每個欄位「怎麼來的、代表什麼」。這四個量表可以分成兩類：**SPMSQ**、**GDS-15** 評估心智狀態；**巴氏量表**、**IADL** 評估日常生活功能。

量表	評估什麼	分數範圍	分數方向	資料欄位
SPMSQ	認知功能	錯 0-10 題	越高越差	spmsq_errors
巴氏量表	基本日常生活活動 ADL	0-100	越高越獨立	adl_barthel
IADL	工具性日常生活活動	0-8	越高越獨立	iadl
GDS-15	憂鬱症狀	0-15	越高越憂鬱	gds15

1. SPMSQ 簡易心智狀態問卷

Short Portable Mental Status Questionnaire (Pfeiffer, 1975)

- **評估**：認知功能，包括定向感、記憶、常識與計算能力。
- **題目**：10 題口頭問答，例如：今天幾月幾號、今天星期幾、這裡是哪裡、你幾歲、你的生日、現任總統是誰、前任總統是誰、母親的姓名，以及從 20 開始連續減 3。
- **計分**：計算答錯的題數，所以分數越高代表認知越差。

答錯題數	解讀
0-2 題	認知功能完整
3-4 題	輕度認知障礙
5-7 題	中度認知障礙
8-10 題	重度認知障礙

- **教育程度校正**：只受過小學教育者可多錯 1 題；受過高中以上教育者應少錯 1 題。
- **特色與限制**：幾分鐘內可完成、不需紙筆，適合長照現場快速篩檢；但它是篩檢工具，**不能用來確診**。

2. 巴氏量表

Barthel Index (Mahoney & Barthel, 1965)

- **評估：**基本日常生活活動 (Activities of Daily Living, ADL)，也就是「照顧自己」的能力。
- **項目：**10 項：進食、床椅間移位、個人衛生、如廁、洗澡、平地行走、上下樓梯、穿脫衣服、大便控制、小便控制。
- **計分：**各項依獨立程度給分，總分 0–100，以 5 分為單位，**分數越高越獨立**。

總分	依賴程度
0–20	完全依賴
21–60	嚴重依賴
61–90	中度依賴
91–99	輕度依賴
100	完全獨立

W5 第 3 堂用 pd.cut 分組時，使用的就是上表的切點。

3. IADL 工具性日常生活活動量表

Instrumental Activities of Daily Living (Lawton & Brody, 1969)

- **評估：**在社區中獨立生活所需的較複雜能力。
- **項目：**8 項：使用電話、購物、備餐、做家事、洗衣、外出搭乘交通工具、自行服藥、處理財務。
- **計分：**每項能獨立完成得 1 分，總分 0–8，**分數越高越獨立**。也有版本將每項分成多個等級計分，總分範圍會不同，使用資料時要先確認是哪一種版本。
- **與巴氏量表的關係：**IADL 通常比 ADL **更早退化**。失智初期往往先出現忘記服藥、無法處理財務等困難，之後才連進食、如廁都需要協助。

4. GDS-15 老人憂鬱量表簡式版

Geriatric Depression Scale – Short Form (Sheikh & Yesavage, 1986)

- **評估：**長者的憂鬱症狀。
- **題目：**15 題「是／否」問題，例如：「你對生活大致滿意嗎？」「你常常覺得無聊嗎？」
- **計分：**0–15 分，**5 分以上疑似憂鬱**，建議進一步評估。
- **限制：**題目需要長者自己理解並回答，認知功能嚴重退化的住民常常**無法施測**。這也是 W5 資料中 GDS-15 缺值最多的原因：缺值本身就可能帶有資訊。

5. 這些量表和機器學習有什麼關係？

這四個量表在長照機構是例行評估，不論是否已確診失智都會施測，因此都符合「**確診前可以取得**」的原則，可以作為模型的輸入變數。

△ 但請注意：失智症的診斷本身就包含「認知功能退化」與「日常生活功能受影響」，所以 SPMSQ、巴氏量表、IADL 與失智診斷本來就高度相關。用這些變數建立的模型，比較接近「**用評估結果做篩檢**」，而不是「**提早預測誰將來會失智**」。W7 建模、W9 用 SHAP 解釋模型時，我們會再討論這個差別。

相對地，**確診之後才產生的資料**（例如失智症用藥、CDR 臨床失智評分、失智專區照護計畫）不能作為預測「是否失智」的輸入，否則等於偷看答案。

參考文獻

1. Pfeiffer E. A short portable mental status questionnaire for the assessment of organic brain deficit in elderly patients. J Am Geriatr Soc. 1975;23(10):433–441. doi:10.1111/j.1532-5415.1975.tb00927.x
2. Mahoney FI, Barthel DW. Functional evaluation: the Barthel Index. Md State Med J. 1965;14:61–65.
3. Lawton MP, Brody EM. Assessment of older people: self-maintaining and instrumental activities of daily living. Gerontologist. 1969;9(3):179–186.
4. Sheikh JI, Yesavage JA. Geriatric Depression Scale (GDS): recent evidence and development of a shorter version. Clin Gerontol. 1986;5(1–2):165–173.
5. Livingston G, et al. Dementia prevention, intervention, and care: 2024 report of the Lancet standing Commission. Lancet. 2024;404(10452):572–628. doi:10.1016/S0140-6736(24)01296-0

註：本課程資料為教學用模擬資料，量表分數由程式生成，不代表任何真實個人。臨床上請依各機構採用的版本與施測規範進行評估。